

**MINISTERE DE LA SANTE ET
DE L'HYGIENE PUBLIQUE**

**REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
UNION- DISCIPLINE-TRAVAIL**

**INSTITUT NATIONAL DE FORMATION
DES AGENTS DE SANTE (INFAS)**

ECOLES DE FORMATION INITIALE

ANNEE ACADEMIQUE 2025-2026



**METHODES ET TECHNIQUES EN
SOINS OBSTETRICAUX
LICENCE 1 2025-2026**

SOMMAIRE

1.	TERMINOLOGIES	6
2.	SOINS MATERNELS ET NEONATALS RESPECTUEUX	7
3.	GENERALITES SUR LES SONU	14
4.	ROLE DE L'IDE/SFM DANS LES SOINS PRENATALS	21
5.	ROLE DE L'IDE/SFM AU COURS DE LA TOILETTE VULVAIRE	24
6.	ROLE DE L'IDE/SFM AVANT ET PENDANT L'ACCOUCHEMENT	26
7.	ROLE DE L'IDE/SFM AU COURS DE L'EXAMEN DU PLACENTA	34
8.	ROLE DE L'IDE/SFM DANS LA SURVEILLANCE DE L'ACCOUCHEE ET DU NOUVEAU-NE DANS LES SUITES DE COUCHES	37

LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES

ATB :	Antibiotique
BDCF :	Bruit Du Cœur fœtal
CAT :	Conduite à tenir
CHR :	Centre Hospitalier Régional
CHU :	Centre Hospitalier Universitaire
CP :	Comprimé
CPN :	Consultation prénatale
CPN 1 :	Première Consultation Prénatale
CSR :	Centre de Santé Rural
CSU :	Centre de Santé Urbain
CU :	Contraction Utérine
DA :	Délivrance Artificielle
DC :	Dilatation Complète
DLG :	Décubitus Latéral Gauche
DPPNI :	Décollement Prématuro du Placenta Normalement Inséré
Ex :	Examen
GEU :	Grossesse Extra Utérine
Grs :	Grammes
HG :	Hôpital Général
Hrgie :	Hémorragie

HRP :	Hématome Rétro Placentaire
HTA :	Hypertension Artérielle
HU :	Hauteur Utérine
IEC/CCC :	Information, Education, Communication pour un Changement de Comportement
IM :	Intra Musculaire
IV :	Intra Veineuse
Mec :	Mise en condition
Mg :	Milligramme
Mn :	Minute
NB :	Note Bien
NFS :	Numération Formule Sanguine
OAP :	Œdème Aigu du Poumon
OMS :	Organisation Mondiale de la Santé
PDE :	Poche Des Eaux
PP :	Placenta Prævia
PP :	Post-partum
RU :	Rupture utérine
RAM :	Rupture Artificielle des Membranes
Rév. U :	Révision utérine
SAT :	Sérum Anti- Tétanique
SP :	Sulfadoxine Pyriméthamine
TA :	Tension Artérielle
VAT :	Vaccin Antitétanique
UI :	Unité Internationale

TPHA /VDRL :	Reponema Pallidum Hemagglutination Assay
	/
HCG :	Venereal Disease Research Laboratory
	Hormone Chorionique Gonadotrope Humaine
ECBU :	Examen Cytobacteriologique

TERMINOLOGIES

GENERALITES

Les terminologies sont un ensemble de vocabulaire, de termes propres à un domaine, à une technique ou à une science spécifique. En gynéco-obstétrique, il est important de se familiariser avec certains termes pour mieux appréhender cette science.

I. DEFINITIONS

- **Gynécologie** : science qui se consacre à l'appareil génital de la femme ou encore discipline médico-chirurgicale qui traite de la physiologie, de la pathologie, et de la physiopathologie de l'appareil génital féminin.
- **Gynécologue** : personne ayant fait des études universitaires de médecine et qui s'est par la suite spécialisée dans le domaine de la gynécologie. On pourra aussi l'appeler gynécologiste.
- **Obstétrique** : discipline médico-chirurgicale qui prend en compte la grossesse, l'accouchement et le post-partum (les suites de couches).
- **Obstétricien(ne)** : vocable donné à celui ou à celle qui pratique l'obstétrique.

NB : la gynécologie et l'obstétrique sont deux disciplines liées, d'où le terme de gynéco-obstétrique. la sage-femme est une obstétricienne à responsabilité limitée (elle n'opère pas)

- **Gestation** : grossesse ou état de grossesse.
- **Gestante** : c'est la femme enceinte ou en grossesse.
- **Geste** : nombre de grossesses antérieures et actuelle.
- **Gestité** : nombre total de grossesse.
- **Nulligeste** : personne n'ayant jamais contracté de grossesse.

- **Primigeste** : personne portant une grossesse pour la première fois.
- **Parturition** : l'acte d'accoucher ou l'accouchement.
- **Parturiente** : personne en travail pour accoucher ou personne entrain d'accoucher.
- **Parité** : nombre d'accouchement antérieur.
- **Primipare** : personne ayant accouché une seule fois.
- **Nullipare** : personne qui n'a jamais accouché.
- **Paucipare** : personne qui n'a eu que peu d'accouchement. La pauci-parité est le fait de n'avoir accouché qu'un petit nombre de fois (2 et au plus 3 fois).
- **Multipare** : personne ayant accouché plusieurs fois (au-delà de 3 fois).
- **Embryon** : produit de conception couvrant les 3 premiers mois de gestation.
- **Fœtus** : au-delà de 3 mois, le produit de conception est appelé fœtus jusqu'à terme.
- **Délivrance** : évacuation du placenta et de ses annexes hors des voies maternelles après la sortie ou l'expulsion du fœtus.
- **Accouchement** : expulsion du fœtus et de ses annexes hors de l'utérus.
- **Césarienne** : accouchement par voie haute qui consiste à faire une intervention chirurgicale sur l'utérus gravide pour extraire le fœtus.
- **Ante-partum** : période avant le travail ou l'accouchement.
- **Post partum** : période qui suit l'accouchement. est aussi les suites de couches.
- **Globe de sécurité** : réaction de l'utérus après la délivrance. C'est le signe de l'hémostase.

- **Involution utérine** : régression progressive de l'utérus après la délivrance jusqu'à sa localisation initiale.
- **Montée laiteuse** : arrivée du lait dans les seins au troisième jour de l'accouchement.
- **Colostrum** : c'est le premier lait de l'accouchée ; il est de couleur jaunâtre et très riche en protéine et en anti corps.
Méconium : premières selles du bébé de couleur vert foncé, son émission est favorisée par la prise de colostrum.
- **Cycle menstruel** : ensemble de modifications hormonales cycliques de l'organisme féminine dont le terme est l'apparition des règles.
- **Menstrues** : règles, écoulement de sang périodique.
- **Ménorrhées** : écoulement des règles.
Nb : menstrues, menstruation, ménorrhée sont synonymes de règles
- **Aménorrhées** : absence de règles.
- **Ménorragie** : augmentation du volume et de la durée des règles (7 à 14 jours).
- **Ménométrorragie** : association des saignements abondants pendant les menstrues et en dehors de celles-ci
- **Spanioménorrhée** : règles ou menstrues très espacées entre les cycles (supérieurs à 45 jours et parfois à 3 mois).
- **Oligomenorrhée** : diminution de la fréquence et du volume des règles.
- **Hyperménorrhée** : règles trop abondante.
- **Hypoménorrhée** : diminution de la quantité des règles.
- **Métrorragie** : perte de sang ou hémorragie d'origine utérine survenant en dehors des règles.
- **Dysménorrhée** : règles douloureuses et difficiles.

- **Ménopause** : cessation des règles consécutive à l'arrêt de l'activité ovarienne chez la femme (arrêt des cycles menstruels).
- **Annexes** : trompes et ovaires.
- **Salpinx** : autre appellation des trompes de Fallope.
- **Hystérectomie** : ablation chirurgicale de l'utérus en partie ou en totalité.
- **Hystérotomie** : ouverture chirurgicale de l'utérus.
- **Myomectomie** : ablation des myomes.
- **Myomes** : tumeurs bénignes constituées de tissus musculaires lisses situés dans la paroi utérine.
- **Salpingite** : inflammation des trompes.
- **Salpingectomie** : ablation chirurgicale des trompes.
- **Hydrosalpinx** : présence d'eau ou de liquide dans les trompes.
- **Hystérogaphie** : radiographie ou exploration de l'utérus.
- **Salpingogaphie** : radiographie ou exploration des trompes.
- **Hystérosalpingographie (HSG)** : exploration de la cavité utérine et des trompes par l'introduction de produit opaque.
- **Ovaire** : gonades femelles où sont produits les ovules.
- **Ovarite** : inflammation de l'ovaire.
- **Ovariectomie** : ablation des ovaires.
- **Métrite** : terme générique donné à toute infection de l'utérus.
- **Dyspareunie** : douleur chez la femme lors des rapports sexuels.
- **Dystocie** : anomalie, difficulté lors du travail d'accouchement.
- **Cervical** : en rapport avec le col de l'utérus.
- **Col utérin** : appelé aussi cervix, est la partie basse de l'utérus qui plonge dans le vagin et doté d'un orifice par lequel s'écoulent les menstrues.
- **Cervicite** : inflammation du col.

- **Curetage** : évacuation du contenu utérin avec un instrument (curette).
- **Curage** : évacuation à l'aide des doigts (digital) du contenu d'une cavité normal ou pathologique (débris placentaires)
- **Dystocie** : anomalie durant l'accouchement.
- **Dystrophie** : conséquence d'un trouble de la nutrition d'un organe.
- **Eutocie** : normal, sans complication.

II. RECAPITULATIF

Nous pouvons tout simplement retenir que les terminologies en gynéco-obstétrique vont de pair avec la racine du mot (éléments irréductibles d'un mot et qui constitue un support de signification). Il faut souligner qu'à cette racine peut s'ajouter soit un préfixe (début), soit un suffixe (fin) et c'est ce qui détermine les terminologies.

Quelques exemples :

- **Ragie** → suffixe — Saignement. Exemple métrorragie.
- **Tomie** → suffixe — hystérotomie Ouverture, incision, section. Exemple :
- **Raphie** → suffixe — réfection. Exemple : hystéroraphie
- **Ecto** → suffixe—ablation. Exemple salpingectomie.
- **Ites** → suffixe — inflammation. Exemple cervicite.
- **Rrhées** → suffixe—écoulement. Exemple : hyperménorrhées.
- **Dys** → préfixe— gêne, difficulté. Exemple : dysménorrhée.
- **Algies** → suffixe — douleur. Exemple pelvialgie.
- **Anté** → préfixe -avant. Exemple : anténatal.
- **Cèle** → suffixe —hernie. Exemple : hydrocèle.
- **Cyst** → préfixe— vessie. Exemple : cystite.
- **Emie** → suffixe sang. Exemple : anémie
- **Ose** → suffixe — maladie chronique inflammatoire.
Exemple : arthroses.
- **Pré** → préfixe—avant. Exemple : pré-éclampsie
- **Sus** → préfixe—au dessus. Exemple : sus hépatique.
- **Pyo** → préfixe—pus. Exemple : pyosalpinx
- **Post** → préfixe— après. Exemple : post-partum.
- **Per** → préfixe—pendant. Exemple : per-coïtal

SOINS MATERNELS ET NEONATALS RESPECTUEUX

INTRODUCTION

Les mauvais traitements, notamment l'humiliation et les paroles blessantes sont récurrents dans nos maternités. En effet, de nombreuses personnes dans le monde subissent un manque de respect et de la violence lorsqu'elles reçoivent des soins maternels.

Ces pratiques n'ont pas leur place dans l'environnement de naissance. Ces mauvais traitements ont des conséquences néfastes sur l'issue de la grossesse (psychologique, voire décès maternel) et la fréquentation des services de santé (CPN, CPON).

Au cours de la dernière décennie, un mouvement populaire pour des soins de maternité respectueux, couramment appelés SMR, a émergé pour s'attaquer à ce problème.

Ce cours est élaboré en vue de préparer les futurs prestataires de soins de maternité à fournir des services de santé essentiels et susceptibles de sauver des vies.

OBJECTIF GENERAL

Connaitre les fondements des soins respectueux basés sur les droits spécifiques des femmes en période périnatale.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Donner la définition des soins respectueux
2. Citer 07 catégories de manque de respect et la charte de la femme en périnatalité
3. Expliquer l'objectif de la charte des femmes enceintes

4. Enoncer les moyens d'amélioration du manque de respect et de mauvais traitements subis par les femmes lorsqu'elles reçoivent des soins de maternité
5. Citer les 11 techniques de communications interpersonnelles positives lors de chaque rencontre avec les clientes

I. DEFINITION DU RESPECT DANS LES SOINS DE MATERNITE

Le respect dans les soins de maternité consiste à considérer la femme comme une participante active à ses soins de santé, ayant des droits et des valeurs qui doivent être respectés. Cela s'applique à l'aide fournie par un prestataire de santé tout au long du continuum des soins (soins prénatals, travail d'accouchement, accouchement et soins postnatals).

II. CATEGORIES DE MANQUE DE RESPECT ET LA CHARTE DE LA FEMME EN PERINATALITE.

- Les catégories de manque de respect sont au nombre de sept (07).

Catégories de manque de respect	Articles correspondant aux droits des femmes enceintes et qui donnent naissance.
1- Violence physique	Le droit de conserver son intégrité et de ne pas être victime de mauvais traitements;

2- Soins administrés sans consentement préalable	Le droit d'être informée adéquatement, d'exprimer son consentement ou son refus libre et éclairé , d'exiger le respect de ses choix et de ses préférences, y compris la présence d'accompagnant(s) auprès d'elle;
3- Non-confidentialité des soins ou violation du secret médical	Le droit à la confidentialité, à la vie privée et à l'intimité.
4- Soins ne respectant pas la dignité de la personne (violence verbale y compris)	Le droit au respect de la vie et de la dignité de la personne
5- Discrimination fondée sur des attributs spécifiques à la patiente	Le droit à l'égalité des soins, l'absence de discrimination et l'équité en matière de soins aux patientes
6- Abandon ou refus de soins	Le droit de recevoir des soins au moment opportun et de jouir du meilleur état de santé possible
7- Détention dans les centres	Le droit à la liberté, l'autonomie et l'autodétermination et elle ne pas être forcée à quoi que ce soit

- La charte de la femme en périnatalité
- ✓ Elle définit des droits fondamentaux pour la mère et le nouveau-né, insistant sur la dignité, l'intimité, l'information et le consentement éclairé et s'oppose aux mauvais traitements, en promouvant le contact « peau à peau », le respect des rythmes physiologiques (allaitement, sommeil), l'accompagnement choisi et des soins basés sur les données probantes (confédération internationale des sages-femmes 09 juillet 2025).
- ✓ Les 10 composantes de la charte de la femme en périnatalité :
 - 1- Chacun et chacune a droit à la protection de son intégrité, sans préjudices ni mauvais traitements
 - 2- Chacun et chacune a droit à l'information, au consentement éclairé et au respect de ses choix et préférences, y compris en ce qui concerne l'accompagnant souhaité durant les soins de maternité et le refus de procédures médicales.
 - 3- Chacun et chacune a droit à la protection de sa vie privée et à la confidentialité.
 - 4- Chacun et chacune constitue une personne à part entière, dès le moment de la naissance et a le droit d'être traité avec dignité et respect.
 - 5- Chacun et chacune a droit à l'égalité, à l'absence de discrimination et à des soins équitables
 - 6- Chacun et chacune a droit aux soins de santé et au meilleur état de santé possible.
 - 7- Chacun et chacune a droit à la liberté, à l'autonomie, à l'autodétermination et à l'absence de détention arbitraire.

- 8- Chaque enfant a le droit d'être avec ses parents ou gardiens.
- 9- Chaque enfant a droit, dès sa naissance, à une identité et à une nationalité.
- 10- Chacun et chacune a droit à une alimentation adéquate et à l'eau propre.

III. OBJECTIF DE LA CHARTE DES DROITS DES FEMMES ENCEINTES ET QUI DONNENT NAISSANCE

Cette Charte a pour objectif de garantir des soins de maternité respectueux, de haute qualité et basés sur les droits humains,

- En protégeant la femme contre la discrimination, les mauvais traitements,
- En lui assurant le pouvoir de décision sur son corps et ses soins, de la grossesse à la période post natale,
- En reconnaissant que ces droits fondamentaux (consentement éclairé, intimité, choix) s'appliquent pleinement durant cette période

IV. MOYENS D'AMELIORATION DU MANQUE DE RESPECT ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS SUBIS PAR LES FEMMES LORSQU'ELLES REÇOIVENT DES SOINS DE MATERNITE

- ✓ Communication communautaire
 - Faire prendre conscience que les droits de la personne reconnus s'appliquent aussi aux femmes, pendant leur grossesse, leur accouchement et la période postnatale ;

✓ Communication individuelle

- Ajuster la perception qu'ont les femmes d'avoir droit à des soins de maternité de haute qualité conformément aux standards internationaux en matière des droits de la personne ;
- Mettre en évidence la connexion entre le langage des droits de la personne et les questions-clés pertinentes aux soins de maternité ;

✓ Renforcement de capacité

- Fournir une base d'informations à partir de laquelle le système de soins de maternité et la communauté seraient tenus responsables vis-à-vis de ces droits.
- Impliquer les défenseurs de la santé maternelle à prendre part aux processus de formation des praticiens ;

✓ Déontologie

- Respect de la déontologie
- Application des sanctions en cas de manquement.

V- TECHNIQUES DE COMMUNICATION INTERPERSONNELLE POSITIVE

L'utilisation de techniques de communication interpersonnelle positives lors de chaque rencontre avec les clientes fait partie des soins respectueux, notamment :

- 1- Assurer le respect de la vie privée (d'un point de vue visuel et sonore) lors des contacts prénataux

- 2- Parler calmement, à voix douce en utilisant des termes et un langage facile à comprendre
- 3- Ecouter la femme / la famille et répondre de manière appropriée (écoute active)
- 4- Les encourager à poser des questions et exprimer leurs préoccupations
- 5- Les encourager à montrer qu'ils ont compris les informations données
- 6- Surveiller les signes inhabituels
- 7- Expliquer toutes les procédures / actions et obtenir la permission avant de continuer
- 8- Faire preuve de respect des croyances culturelles et des normes sociales
- 9- Être empathique et ne pas juger
- 10- Eviter les distractions lors du contact
- 11- Remercier la cliente et lui rappeler quand revenir

CONCLUSION

Les soins respectueux sont une compétence qui sauve la vie. Le traitement et les soins prodigués à chaque femme devraient l'encourager à revenir régulièrement dans votre établissement pour recevoir des soins.

GENERALITES SUR LES SONU

INTRODUCTION

La mortalité maternelle et néonatale reste élevée dans nos pays à ressources limitées. C'est dans ce cadre que les SONU ont été mis en place pour réduire ce fléau.

OBJECTIF GENERAL

Connaitre l'importance des SONU dans la prévention de la mortalité maternelle et néonatale

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Donner la définition des concepts
2. Enumérer les causes de mortalité maternelle
3. Expliquer les facteurs de mortalité maternelle
4. Citer les fonctions des établissements des SONU

I. Définitions des concepts

- Soins Obstétricaux Et Néonataux D'urgence (SONU)

Définis comme des soins offerts en urgence à toute femme et/ou à son enfant, présentant des complications au cours de la grossesse, du travail et des suites de couches

- Mortalité maternelle

Selon l'OMS (2018), la mortalité maternelle est le décès d'une femme pendant la grossesse, l'accouchement ou dans les 42 jours suivant le terme, pour toute cause liée ou aggravée par la grossesse, l'accouchement ou les soins post-partum, et non par accident ou cause fortuite.

❖ MORTALITE INFANTILE

La mortalité néonatale désigne les décès d'enfants nés vivants et décédés à moins de 28 jours

. CONTEXTE

Les estimations de l'OMS portent à 260 000 femmes sont décédées pendant ou après une grossesse ou un accouchement en 2023. Plus de 700 femmes sont mortes de causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement. Plus d'une femme meurt chaque minute de causes liées à la grossesse (OMS, 2025).

99% des décès maternels de nos jours surviennent en Afrique, Asie et Amérique latine. La plupart des complications obstétricales ne peuvent être ni prévues ni prévenues. Mais si les femmes reçoivent un traitement efficace à temps, presque toutes d'entre elles peuvent être sauvées.

Dans l'espace CEDEAO, *Chaque jour*

- 225 femmes meurent en donnant la vie
- 1.197 nouveau- nés meurent

En Côte d'Ivoire • Mortalité maternelle élevée : 385 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2021-2022 (EDS 2021)

- Très loin de l'ODD de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes d'ici à 2030.
- Mortalité néonatale : 30 /1.000

II. CAUSES DE MORTALITE ET INCAPACITE MATERNELLE

II.1. Causes de décès obstétricales directes (COD)

Ce sont celles qui résultent de complications obstétricales (grossesse, travail et suites des couches), d'interventions, d'omissions d'un traitement correct ou d'un enchaînement d'événements résultant de l'un des facteurs ci-dessous.

- | | |
|---|-----|
| - Hémorragie | 51% |
| - Avortement à risques | 03% |
| - HTA ET COMPLICATION | 13% |
| - AVORTEMENT | 03% |
| - Infections | 08% |
| - Autre (embolie amniotique, trouble ...) | 22% |

Ces causes directes représentent environ les 3/4 des décès maternels

II.2. Causes de décès obstétricales indirectes (COI)

Ce sont celles qui résultent d'une maladie préexistante ou d'une affection apparue au cours de la grossesse sans qu'elle soit due à des causes obstétricales mais qui a été aggravée par les effets physiologiques de la grossesse.

- Le paludisme,
- L'anémie et l'hépatite
- Le VIH/SIDA

Ces causes indirectes représentent environ 1/4 des décès maternels.

• OÙ meurent les femmes de nos jours ?

99% des décès maternels de nos jours surviennent en Afrique, Asie et Amérique latine

La plupart des complications obstétricales ne peuvent être ni prévues ni prévenues Mais si les femmes reçoivent un traitement efficace à temps Presque toutes d'entre elles peuvent être sauvées

• De combien de temps disposons-nous ?

L'on estime qu'en l'absence de traitement, le décès va survenir en moyenne en :

- 02 heures suite à l'hémorragie du postpartum
- 12 heures suite à l'hémorragie anté-partum
- 02 jours suite au travail dystocique
- 06 jours suite à l'infection

II.3. Incapacité maternelle

C'est une maladie à court ou à long terme causée par des complications obstétricales

☐ Type de morbidité

- Infections pelviennes
- Incontinence urinaire
- Infertilités
- Anémies graves
- Fistules obstétricales : la plus grave (Passage anormal entre le vagin et la vessie ou le rectum, souvent causé par un travail dystocique qui n'est pas traité par césarienne)

III. FACTEURS DE LA MORBIDITE MATERNELLE

III.1 Concept des trois retards

- ☐ 1^{er} Retard : retard à la prise de décision

Il est lié à la patiente, à son entourage et à la communauté

- Méconnaissance des signes de danger
- Lenteur dans la prise de décision
- Faible pouvoir de décision de la femme
- Faible revenu des ménages

➤ 2^{ème} Retard : retard à l'accès à une structure de soin. Il est lié à l'accessibilité géographique

- Longues distances
- Mauvais état des routes
- Insuffisance de moyens de référence adéquats
- Faible revenu des ménages

➤ 3^{ème} Retard : retard à la prise en charge (qualité des soins dans le système de santé)

- ☐ **Insuffisance :**

- En personnel
- En équipement
- En médicaments et consommables
- Dans la disponibilité des interventions

- ☐ **Faible motivation du personnel**

- Mauvais accueil dans les structures de soins
- Faible promptitude dans l'offre des soins

III.2 Facteurs liés à la procréation

- ☐ Les "4TROP"

- Grossesses **trop** précoces, âge < 18 ans
- Grossesses **trop** tardives : âge > 35 ans
- Grossesses **trop** nombreuses : Parité > 4
- Grossesses **trop** rapprochées) : Espace inter génésique < 2 ans

- ☐ Les avortements non sécurisés pour grossesses non désirées.

III.3 Facteurs économiques

- Pauvreté
- Vulnérabilité économique
- Absence de couverture maladie
- Absence de planification économique

IV. FONCTIONS DES SONU

IV.1. Fonctions des SONU de base

Les fonctions des SONU de base sont :

1. Administration d'antibiotiques (par voie intraveineuse ou injection IM)
2. Administration de médicaments ocytotiques (par voie intraveineuse ou injection IM)
3. Administration d'anticonvulsivants (par voie intraveineuse ou injection IM)
4. Délivrance artificielle

5. Extraction des produits retenus de la conception
6. Accouchement par voie basse avec assistance
7. Soins essentiels au nouveau-né (réanimation)

Les SONU complets

Les fonctions des SONU complets sont

1. Antibiotiques (par voie intraveineuse ou injection IM)
2. Médicaments ocytotiques (idem)
3. Anticonvulsivants (idem)
4. Délivrance artificielle
5. Extraction des produits retenus de la conception
6. Accouchement par voie basse avec assistance
7. La réanimation du nouveau-né
8. Interventions obstétricales majeures (césarienne et hystérectomies etc.)
9. Transfusion de sang

CONCLUSION

La plupart des complications obstétricales ne peuvent être ni prévues ni prévenues mais si les femmes reçoivent un traitement efficace à temps, presque toutes d'entre elles peuvent être sauvées. Tout pays peut éviter la mortalité et l'incapacité maternelles s'il rend les SONU disponibles et accessibles à temps

ROLE DE LA SFM / L'IDE DANS LES SOINS PRENATALS

INTRODUCTION

Le rôle de la SF /M ET IDE est primordial dans les soins prénatals ; car il permet d'améliorer les indicateurs de mortalité maternelle et infantile

OBJECTIF GENERAL

Ce cours va permettre aux apprenants de la licence 1 en sciences infirmière et obstétricale de connaître les bases fondamentales des soins prénatals.

Objectifs spécifiques

A la fin de ce cours, l'étudiant de la licence 1 doit être capable de :

- 1) Donner la définition des soins prénatals ;
- 2) Citer les 3 buts des soins prénatals
- 3) Enoncer les 4 principes des soins prénatals
- 4) Décrire les principales composantes des soins prénatals ;

I. DEFINITION

Les soins prénatals, englobent les interventions orientées vers un but et axées sur les besoins des gestantes. Ils sont adaptés à tous les pays et sont parfaitement ciblés à travers une évaluation des besoins et des soins individuels autour des principaux problèmes affectant les gestantes et leur fœtus.

5. Extraction des produits retenus de la conception
6. Accouchement par voie basse avec assistance
7. Soins essentiels au nouveau-né (réanimation)

Les SONU complets

Les fonctions des SONU complets sont

1. Antibiotiques (par voie intraveineuse ou injection IM)
2. Médicaments ocytotiques (idem)
3. Anticonvulsivants (idem)
4. Délivrance artificielle
5. Extraction des produits retenus de la conception
6. Accouchement par voie basse avec assistance
7. La réanimation du nouveau-né
8. Interventions obstétricales majeures (césarienne et hystérectomies etc.)
9. Transfusion de sang

CONCLUSION

La plupart des complications obstétricales ne peuvent être ni prévues ni prévenues mais si les femmes reçoivent un traitement efficace à temps, presque toutes d'entre elles peuvent être sauvées. Tout pays peut éviter la mortalité et l'incapacité maternelles s'il rend les SONU disponibles et accessibles à temps

ROLE DE LA SFM / L'IDE DANS LES SOINS PRENATALS

INTRODUCTION

Le rôle de la SF /M ET IDE est primordial dans les soins prénatals, ; car il permet d'améliorer les indicateurs de mortalité maternelle et infantile

OBJECTIF GENERAL

Ce cours va permettre aux apprenants de la licence 1 en sciences infirmière et obstétricale de connaître les bases fondamentales des soins prénatals.

Objectifs spécifiques

A la fin de ce cours, l'étudiant de la licence 1 doit être capable de :

- 1) Donner la définition des soins prénatals ;
- 2) Citer les 3 buts des soins prénatals
- 3) Enoncer les 4 principes des soins prénatals
- 4) Décrire les principales composantes des soins prénatals ;

I. DEFINITION

Les soins prénatals, englobent les interventions orientées vers un but et axées sur les besoins des gestantes. Ils sont adaptés à tous les pays et sont parfaitement ciblés à travers une évaluation des besoins et des soins individuels autour des principaux problèmes affectant les gestantes et leur fœtus.

II. BUT DES SOINS PRÉNATALS

Des soins prénatals optimaux peuvent réduire la morbidité et la mortalité périnatales par les moyens suivants :

- détection et réduction des risques potentiels,
- traitement des affections médicales,
- soutien psychologique et promotion d'un mode de vie plus sain.

III. PRINCIPES DES SOINS PRÉNATALS

Assurer aux mères et aux nouveau-nés des soins respectueux, individualisés, centrés sur la personne à chaque contact en mettant en œuvre des pratiques cliniques efficaces par des praticiens compétents pour garantir une issue favorable de la grossesse, à la mère et au nouveau-né

Les soins prénatals sont des soins basés sur 4 principes qui insistent sur :

1. Des actions basées sur l'évidence et orientée vers un objectif
2. Des soins individualisés axés sur chaque femme
3. La qualité des visites par opposition à leur nombre en faisant une analyse pertinente des résultats de la séance de CPN
4. Des soins donnés par des prestataires compétents.

IV. COMPOSANTES DES SOINS PRÉNATALS

IV.1 Identification des risques : Dépistage et PEC des maladie préexistantes et des complications

- Paludisme (fièvre, anémie, goutte épaisse / Frottis ou test de diagnostic rapide)
- Infections urinaires (dysurie, pollakiurie, fièvre, douleurs pelviennes, lombaires, ECBU)
- Pré éclampsie (HTA, œdèmes des membres inférieurs, reflexes tendineux, protéinurie)
- Anémie (pâleur des conjonctives, des paumes, de la langue ; taux d'hémoglobine et d'hématocrite)
- Maladie des seins (douleurs mammaires, nodules mammaires, écoulement mammaire anormal)
- Retard de croissance, mort fœtale (MAF, HU, BDCF)
- Infections sexuellement transmissibles (leucorrhées, condylomes vulvaires, examen pelvien et au spéculum)
- Cancer du col (Inspection visuelle, examen pelvien et au spéculum)

IV.2 Prévention et prise en charge des pathologies survenant au cours ou induite par la grossesse :

- Vaccination antitétanique
- Supplémentations en fer/folate
- Prévention du paludisme
- Prévention des troubles dus à la carence en iode par consommation de sel iodé

IV.3 Education à la santé et à la promotion de la santé.

Elle peut se faire au centre de santé ou dans la communauté à travers plusieurs thèmes de CCC en rapport avec la situation actuelle de la femme (prévention du paludisme, l'alimentation de la femme enceinte et du nouveau-né, l'hygiène générale, la planification familiale etc.)

IV.4 Préparation à l'accouchement et aux complications éventuelles

-Identifier :

- Prestataire qualifié pour l'accouchement
- Lieu de l'accouchement
- Moyens de transport pour se rendre à l'hôpital
- Moyens financiers
- Système de prise de décisions en cas d'urgence
- Donneurs de sang
- Soutien familial pendant le séjour à la maternité
- Articles nécessaires pour le jour de l'accouchement.

- Vérifier que la femme connaît les signes de :

Danger pendant la grossesse

V. MOMENT/ PERIODICITE DES SOINS PRENATALS

La fréquence requise pour les soins prénatals est de huit (08) consultations au minimum pendant la grossesse et sont réparties selon le calendrier suivant :

PERIODE	NOMBRE DE CONTACT
Premier trimestre : dès le 1er jour d'absence de règles jusqu'à 12 semaines	Contact 1 : La première visite prénatale s'effectue avant la fin du troisième mois
Deuxième trimestre	La deuxième : 20 semaines La troisième visite à 26 semaines
Troisième trimestre	Contact 4 : 30 semaines Contact 5 : 34 semaines Contact 6 : 36 semaines Contact 7 : 38 semaines Contact 8 : 40 semaines
Revenir pour l'accouchement à 41 semaines si l'enfant n'est pas encore né. Remarque : Le traitement intermittent préventif du paludisme pendant la grossesse doit être administrée au début du deuxième trimestre jusqu'à l'accouchement en respectant l'intervalle de 4 semaines entre les prises (5 doses au cours de la grossesse) NB : Si elle a des problèmes entre les rendez-vous elle doit se rendre à la formation sanitaire sans attendre.	

VI. BILAN AU COURS DE LA GROSSESSE

- Groupe sanguin (ABO + Rhésus)
- Sérologie de la toxoplasmose (si négatif surveiller tous les mois)
- Sérologie de la rubéole (au 1^{er} Trimestre)
- Sérologie de la syphilis (VDRL – TPHA)
- NFS (Taux d'hémoglobine et hématocrite)
- Albumine – sucre dans les urines (à toutes les CPN)
- Nitrite dans les urines (si positif faire un ECBU)
- Sérologie VIH après consentement éclairé
- Sérologie de l'hépatite B (Antigène HBs)
- Examen d'échographie (03)
 - 1^{ère} pour le diagnostic de grossesse au 1^{er} Trimestre
 - 2^{ème} pour la morphologie fœtale au 2^{ème} Trimestre
 - 3^{ème} pour le pronostic de l'accouchement au 3^{ème} Trimestre

VII. CONDUITE A TENIR

7.1. Traitement curatif si nécessaire

7.2. Prévention des complications et des maladies

Chaque femme enceinte doit bénéficier des mesures préventives suivantes :

- Vaccination antitétanique
- Supplémentation en fer/folate

- Prévention du paludisme
- Déparasitage
- Prévention des troubles dus à la carence en iode par consommation de sel iodé.

VIII. Promotion de la santé

Elle peut se faire au centre de santé ou dans la communauté à travers plusieurs thèmes de CCSC en rapport avec la situation actuelle de la femme (prévention du paludisme, l'alimentation de la femme enceinte et du nouveau-né, l'hygiène générale, la planification familiale etc.)

CONCLUSION

La sage-femme/maieuticien et l'IDE sont un pilier central des soins prénatals, offrant un suivi médical et psychologique complet, de la prévention à l'orientation, pour garantir le bien-être de la mère et du bébé dans un parcours de soins coordonné

ROLE DE LA SF/ IDE AU COURS DE LA TOILETTE VULVAIRE

OBJECTIF GENERAL

Connaitre la technique de la toilette vulvaire

Objectifs spécifiques

- 1) Donner l'indication de la toilette vulvaire ;
- 2) Citer le matériel nécessaire
- 3) Décrire la technique de la toilette vulvaire

I- INDICATION

Soins de maternité.

II- MATÉRIEL

- 1 à 2 serviettes hygiéniques
Antiseptique (Si épisiotomie : povidone iodée, éosine ...)
- Sérum physiologique/ eau bouillie tiédie
- Gants stériles ou gants propres
- Compresses stériles
- Pince à cœur
- Bassin
- Plateau stérile
- Chariot
- Poubelle

III- TECHNIQUE

- Préparer le matériel

- Installer la patiente sur la table d'examen,
- Glisser la protection (alèze et absorbex), le bassin ou un morceau de pagne propre
- Faire plier les jambes et les recouvrir avec un drap ;
- Apprécier la couleur et l'odeur des écoulements
- Imbiber les compresses d'antiseptique
- Mettre les gants stériles
- Nettoyer le périnée
- Nettoyer les petites et les grandes lèvres
- Nettoyer le vestibule et le méat
- Essuyer avec des compresses sèches stériles si épisiotomie : Appliquer de l'éosine et laisser sécher
- Mettre une serviette hygiénique à la suite du soin
- Faire l'asepsie du matériel et le ranger
- Noter le soin

ROLE DE LA SF/M ET DE L'IDE AVANT ET PENDANT L'ACCOUCHEMENT

INTRODUCTION

La sage-femme, le maïeuticien et l'infirmier sont des professionnels clé qui accompagnent la femme et le nouveau-né avant, pendant et après l'accouchement. Leur rôle est d'assurer l'accouchement physiologique et de prodiguer les soins postnataux essentiels, en veillant au bien-être de la mère et du nouveau-né.

OBJECTIF GENERAL

Connaitre les soins obstétricaux avant, pendant et après l'accouchement

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Donner la définition de l'accouchement,
2. Citer les 3 phases de l'accouchement
3. Décrire les éléments des soins avant et pendant l'accouchement
4. Décrire les éléments des soins après l'accouchement

I. GENERALITES

I.1 Définition de L'accouchement

Ensemble des phénomènes physiologiques et mécaniques qui ont pour conséquence la sortie du fœtus et de ses annexes hors des voies génitales maternelles.

I.2 Phases de l'accouchement

L'accouchement se déroule en 3 phases :

- Le travail d'accouchement : il se déroule en plusieurs étapes successives et inter dépendantes (marquée par les contractions utérines, l'effacement et la dilatation du col, la descente du fœtus vers le bassin).
- L'expulsion du fœtus : la traversée du détroit inférieur (dégagement)
- La délivrance : la sortie du placenta et des annexes fœtales (Gestion Active de la Troisième Phase de l'Accouchement : GATPA)

II. Rôle de la SF/M et de L'IDE avant l'accouchement

II.1 Accueil et installation de la Parturiente

En fonction de l'état de la parturiente à l'arrivée, la SF/M ou l'IDE doit :

- L'installer en salle d'accouchement.
- Prendre les constantes (pouls, TA, température, contrôle albumine, sucre)
- Recueillir des informations afin de fixer les priorités, sur :
 - ✓ Le terme de la grossesse,
 - ✓ La rupture ou non de la poche des eaux (heure), perte du bouchon muqueux, présence ou non de contractions utérines
 - ✓ Sensations particulières (gêne dans le bas ventre, envie de pousser irrésistible)
- Prendre une voie veineuse périphérique si nécessaire
- Préparer le matériel nécessaire pour l'accouchement.

II.2 Préparation du matériel de naissance

La préparation de la salle de naissance est indispensable et doit être réalisée avec précision.

➤ Matériel d'accouchement

- Set ou boîte d'accouchement :
 - ✓ 2 pinces de Kocher pour clamber le cordon ombilical
 - ✓ 1 paire de ciseaux
 - ✓ 2 Pinces hémostatiques,
 - ✓ 1 Porte aiguille,
 - ✓ 1 Valve vaginale
- Champs et compresses stériles
- Kit d'accouchement / épisiotomie
- Gants stériles
- Petit matériel (Pince de Barr, seringues, aiguilles, sonde urinaire, fils de suture 2/0 ou 0)
- Antiseptiques,
- Xylocaïne
- Chariot
- Bassin.
- Matériel de réanimation pour le nouveau-né :
 - Respirateur de néonatalogie ou ambu manuel
 - Source d'oxygène
 - Aspirateur bronchique ou pingouin,
 - Sonde d'aspiration
 - Stéthoscope médical
 - Ecouvillons stériles pour divers prélèvements
 - Seringues et aiguilles stériles
 - Thermomètre

➤ Matériel de pansement ombilical

- ✓ Chlorhexidine ou alcool à 60°
- ✓ Compresses
- ✓ Bande (si pansement avec alcool)
- ✓ Plateau
- ✓ Haricot

II.3 Surveillance maternelle et fœtale

Ils sont transcrits sur le partogramme dès la phase active du travail d'accouchement (à 4 cm de dilatation cervicale).

▪ Eléments de surveillance maternelle

- Contractions utérines
- Dilatation du col
- Progression du mobile fœtal
- Constantes (TA, pouls, T°)
- Urines (protéines, sucre, volume)
- Médicaments
- Etat de conscience

▪ Eléments de surveillance fœtale

- Le rythme cardiaque fœtal
- Liquide amniotique (rupture, aspect, quantité)
- Modélation de la tête fœtale

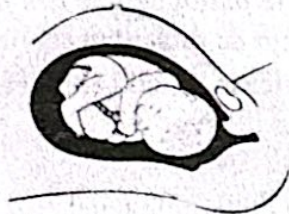
▪ Préparation de la femme

- Vider la vessie, faire la toilette vulvaire, rassurer la patiente et la guider pour les efforts expulsifs.

III. Rôle de la SF/M et de L'IDE pendant l'accouchement

III.1 Au moment de l'expulsion

- Protéger le périnée
- Guider les efforts expulsifs pour qu'ils soient efficaces.
- Diriger l'expulsion fœtale
- Accueillir le nouveau-né



B. Engagement fœtal descendant

1. L'engagement de la tête en position occipito iliaque gauche antérieure



D. Rotation complète, début de l'extension

2. La descente et la rotation en position occipito pubienne

3. Le dégagement



E. Extension complète

4. L'expulsion de la tête



F. Résultant

5. L'accouchement des épaules



G. Expulsion de l'épaule antérieure

III.2 Délivrance

• Délivrance normale

Elle s'effectue en 5 phases :

- Phase de rémission (durée environ 15 mn)
- Phase de décollement - Phase de migration
- Phase d'expulsion
- Phase d'hémostase

▪ Délivrance par la GATPA

Elle s'effectue en trois étapes :

- Injection d'ocytocine (10 UI en IM)
- Traction contrôlée du cordon
- Massage utérin

III.3 Soins immédiats du nouveau-né

- Etape 1 : Sécher et stimuler le nouveau-né
- Etape 2 : Evaluer la respiration et la coloration (cri)
- Etape 3 : Evaluer les besoins de réanimation
- Etape 4 : Maintenir le nouveau-né au chaud (contact peau à peau)
- Etape 5 : Ligaturer et sectionner le cordon ombilical (après cessation des battements)
- Etape 6 : Identifier le nouveau-né (sexe, nom de la mère)
- Etape 7 : Appliquer le collyre
- Etape 8 : Peser le nouveau-né et prendre ses mensurations
- Etape 9 : Administrer la vitamine K1
- Etape 10 : Effectuer les soins du cordon (Chlorhexidine)
- Etape 11 : Initier l'allaitement

RÔLE DE LA SF/M ET DE L'IDE AU COURS DE L'EXAMEN DU PLACENTA

INTRODUCTION

L'examen du placenta doit être systématique après l'accouchement. Le délivre doit faire l'objet d'un examen minutieux de la part du personnel soignant (sage-femme, maieuticien, infirmier).

OBJECTIF GENERAL

Connaitre les éléments de l'examen du placenta après la délivrance.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Enoncer les buts de l'examen du placenta
2. Décrire les éléments à rechercher sur chaque face du placenta

I- BUTS

L'examen du placenta permet de :

- S'assurer de l'intégralité du placenta et des membranes, ceci pour prévenir une hémorragie ;
- Expliquer un certain nombre d'accidents comme la mort in utero en rapport avec un nœud du cordon ou une sénescence placentaire précoce ;
- Confirmer un diagnostic de placenta prævia et d'hématome retro placentaire (PP, HRP)
- Faire des prélèvements complémentaires pour des diagnostics précoces.

II- TECHNIQUE DE L'EXAMEN

Commencer par peser le placenta, son poids représente 1/6 du poids du nouveau-né.

II.1. Examen de la face maternelle

- Recueillir le placenta dans le plateau et le déposer sur une surface plane (paillasse ou table)
- Débarrasser la face des caillots à l'aide des compresses
- Tenir le placenta dans les paumes des mains, la face maternelle vers le haut et vérifier que tous les cotylédons sont en place et bien ensembles.

□ Eléments à rechercher

- Une zone dépolie rugueuse qui marque l'absence d'un ou plusieurs cotylédons. Dans ce cas, une révision utérine s'impose.
- Une zone de dépression due à la présence de caillots noirâtres sur la face interne du placenta : signe d'un hématome retro placentaire.
- Des dépôts inter villosités et des calcifications : ce sont des lésions blanchâtres qui donnent une sensation granuleuse à la palpation, (signe de vieillissement du placenta).

II.2. Examen de la face fœtale

- Tenir le cordon d'une main et laisser pendre le placenta et les membranes
- Insérer l'autre main dans les membranes, les doigts écartés
- Vérifier l'intégrité des membranes

□ Eléments à rechercher

- Vérifier la présence des deux membranes (le chorion et l'amnios) normalement translucides et vérifier si elles sont complètes. Leur irrégularité impose une révision utérine à la recherche du reste des membranes.
- Mesurer le petit côté des membranes (sa mesure normale est supérieure ou égale à 10 cm). Un petit côté mesurant moins de dix centimètres nous fait penser à un placenta prævia ou un placenta bas inséré.
- Examen du cordon : mesurer la longueur du cordon. (Le cordon normal mesure entre 50 et 70 cm). On peut noter parfois des anomalies :
 - ✓ Longueur inférieure à 40 cm (peut gêner l'accouchement par voie basse)
 - ✓ Longueur supérieure à 70 cm (favorise les circulaires observées et les bretelles dans 20 à 25% des accouchements).
 - ✓ Déterminer l'insertion du cordon ombilical (En général, l'insertion du cordon ombilical est centrale). Cependant des anomalies peuvent être observées (une insertion en **raquette** : cordon sur le bord du placenta, une insertion **Velamenteuse** : cordon sur les membranes, une insertion **marginale** : cordon excentré).
 - ✓ Vérifier la présence des trois vaisseaux : deux artères et une veine (la veine est plus grosse que les deux artères).
 - ✓ Prélever du sang au niveau du cordon si des examens sont demandés.

ROLE DE LA SF/M ET DE L'IDE DANS LA SURVEILLANCE DE L'ACCOUCHEE ET DU NOUVEAU-NE DANS LES SUITES DE COUCHES

INTRODUCTION

La SFM /IDE joue un rôle central dans la surveillance du postpartum. Ils assurent le suivi physique et psychologique de la mère pendant les suites de couches. Cette surveillance de l'accouchée doit être régulière avec une fréquence adaptée aux facteurs de risques.

OBJECTIF GENERAL

Connaitre les éléments de surveillance du couple mère-enfant dans les suites de couches

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Donner la définition des suites de couches

- 1) Citer les éléments de la fiche de surveillance de la mère et le nouveau-né
- 2) Décrire les soins au nouveau-né

I. GENERALITES

I.1 Définition des suites de couches

Selon l'OMS, les suites de couches (post-partum) désignent la période de 42 jours (6 semaines) après l'accouchement, moment crucial pour la récupération physique, émotionnelle et marquée par une surveillance.

I.2 Différentes périodes de suites de couches

Selon l'OMS, la période des suites de couches se divise en 2 phases : SDC immédiates et tardives

▪ Suites de couches immédiates

Elles désignent les quinze premiers jours suivant la délivrance

▪ Suites de couches tardives

Elles partent du 15 -ème jour jusqu'au retour des couches.

II. ELEMENTS DE LA SURVEILLANCE

II.1 Chez la mère

Cette surveillance clinique et paraclinique doit être retranscrite sur le dossier médical. Sont notés :

- L'heure précise du 1^{er} examen ; - Le nom de l'examineur ;
- Les constantes hémodynamiques (TA, pouls, T°, état de conscience)
- L'involution, la consistance et la sensibilité utérine :
 - ✓ Après l'accouchement et la délivrance complète, le fond utérin se situe à l'ombilic ; il est tonique, ferme. C'est ce que l'on appelle le globe utérin de sécurité ;
 - ✓ L'expression manuelle à travers la paroi abdominale doit ramener des pertes fluides rouges non constantes et sans caillots. L'expression utérine est un acte médical douloureux.

Devant un utérus plus ou moins atone, la mobilisation manuelle à travers la paroi abdominale ainsi qu'une perfusion IV d'utéro tonique (Syntocinon®) sont les premiers gestes qui devraient permettre sa rétraction. Le

globe utérin dit de sécurité doit être constant en post-partum

- la quantité et la nature des saignements :

faire la distinction entre des pertes fluides rouges, la présence de caillots (saignement actif ou non)

II.2 Chez le nouveau-né

- **Cotation d'Apgar :** Ce score permet d'évaluer les fonctions vitales d'un nouveau-né dans les minutes qui suivent la naissance en appréciant 5 critères cliniques cotés de 0 à 2.

Il est mesuré à 1,5, 10 mn de vie.

Le score doit être supérieur ou égal à 7.

Si l'Apgar est inférieur à 3, il faut considérer que l'on est face à un état de mort apparente et débiter les manœuvres de réanimation

Critère	Cotation	Cotation	Cotation
	0	1	2
Fréquence Cardiaque	< 80 par mn	80 à 100 par mn	>100 par mn
Respiration	0	Cri faible	Cri vigoureux
Tonus	0	Extrémités	Normal
Réactivité	0	Grimace	Vive
Coloration	Bleue ou blanche	Imparfaite	Rose

	Normal	Risque
Température	Instable, 1 ^{ère} surveillance toutes les 4 H	Hypothermie (incubateur)
Poids	Baisse du poids physiologique de 1/10, retrouve son poids de naissance au 5 ^{ème} jour ensuite prise de 20 à 25 g par jour	Baisse de poids anormal (déshydratation, courbe qui ne remonte pas)
Alimentation	Précoce contre l'hypoglycémie, 6 à 7 tétées par 24 H	Pas de succion, refus de boire, vomissements, régurgitations
Respiration	Régulière, sans bruit, enfant rosé	Respiration bruyante, dyspnée, essoufflements pendant les biberons
Température	Méconium dans les premières 24- 48H - au sein ; selles jaune, granuleuse à chaque tété, - au biberon ; selles jaune clair, molle, liquide, constipation possible	Retard du méconium, Diarrhée, constipation

- le tonus (hypotonie axiale, hypertonie des membres)

III. SOINS AU NOUVEAU-NE

- **Désobstruction rhino-pharyngée** : le cri doit être violent, l'enfant doit rosir. On effectue une désobstruction buco-pharyngée par aspiration douce pour évacuer les sécrétions dans l'arrière gorge.
- **Aspiration gastrique** (avec la même sonde que pour la désobstruction) pour dépister les atrésies de l'œsophage ou test à la seringue, envoyer de l'air dans l'estomac (5 cc) et voir si les voies sont perméables en fonction du bruit.
- Essuyer délicatement le nouveau-né avec des linges chauds et secs immédiatement après sa naissance pour enlever le sang.

NB : L'OMS, il faut retarder le premier bain du nouveau-né d'au moins 24 heures (ou au minimum 6 heures) pour éviter l'hypothermie et préserver le vernix de caseosa, cette fine couche protectrice naturelle.

- **Régulation thermique** : les examens se font sous la lampe chauffante pour éviter les déperditions thermiques. Habiller rapidement après le bain (prévoir chemise, brassières, bonnet) pour éviter tout refroidissement.
- **Soins des yeux** : les désinfecter avec un collyre antibiotique car les yeux ont été en contact avec les parties génitales de la mère et il faut absolument éviter l'ophtalmie purulente à gonocoques).
- **Mensurations** :
Poids = 3,250kg
Taille = 50 cm PC = 35 cm
TA = 74/47 mmHg ; p = 180 à la naissance
- **Alimentation** dès la première heure dans la salle de travail si la mère désire allaiter.
- **Observation de tout le corps** : extrémités bleutées, vernix caseosa, millium, lanugo, tâches mongoliennes.

Morphologie générale, sexe de l'enfant, fontanelle antérieure bien visible, fente labio-palatine, luxation de la hanche.

• Section du cordon

Il doit être blanc et gélatineux. Clamper à 1 ou 2 cm de l'abdomen.

Désinfecter la tranche de section, mettre une compresse stérile dessus ; il y a 2 artères et une veine.

Un prélèvement doit être effectué sur le cordon pour dépister une anomalie.

Le cordon tombe vers les 7^{ème} - 10^{ème} jours. On peut donner un bain même avant.

- Vérification des choanes ;

Si la sonde ne passe pas = anormal

- Vérification de l'anus

Introduire un thermomètre pour vérifier la perméabilité

- Identification de l'enfant

Devant la mère et ne doit jamais être enlevé

- Température

Dans les 5 premiers jours

- Appréciation des différents appareils :

- maturité et adaptation.
- Dépistage des maladies curables en urgence (phénylcétonurie, hypothyroïdie, mucoviscidose)
- maturité (neurologique, hépatique, rénale urinaire et digestive.)

NB : Le test de Guthrie permet le dépistage de la phénylcétonurie, hypothyroïdie, mucoviscidose : Se fait au 3^{ème} jour, quand l'enfant a mangé ; prise de sang au talon, mettre une goutte de sang dans les 6 cercles de la carte.

- **Déclaration de naissance à faire dans les 3 jours.**